ESE Hospital Sintético San Jerónimo

Código de habilitación 230010999903 · HISTORIA CLÍNICA DE HOSPITALIZACIÓN

DATOS DEL PACIENTE

USUARIO: DAVID TOMAS ORTIZ RICARDO DOCUMENTO: CC 1035958274 EDAD: 63 años SEXO: MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO: 28-05-1962 PROCEDENCIA: Sincelejo DIRECCIÓN: Avenida 55 # 26-96

TELÉFONO: 316 509 1355 ASEGURADORA: Nueva EPS HISTORIA: HC-2026-6769 EPISODIO: ADM-779713

FECHA DE INGRESO: 18-03-2026 17:17 SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN

MOTIVO DE CONSULTA

«Dolor fuerte en la barriga del lado derecho».

ENFERMEDAD ACTUAL

Dolor en hipocondrio derecho de 24 horas, intensidad 8/10, irradiado a la espalda, con vómito en tres ocasiones y fiebre subjetiva. Intolerancia a grasas de larga data.

Según refiere su familiar Monica Paola Rodriguez Guerrero, el cuadro empeoró en las últimas horas.

ANTECEDENTES

Personales: colelitiasis conocida hace dos años. Familiares: sin relevancia. Alérgicos: niega.

EXAMEN FÍSICO

TA 132/86 mmHg, FC 102 lpm, FR 20 rpm, T 38,4 °C. Signo de Murphy positivo, sin signos de irritación peritoneal generalizada.

ANÁLISIS

Colecistitis aguda litiásica; se hospitaliza para manejo quirúrgico.

Se realiza citología cervicouterina de tamizaje durante la consulta.

DIAGNÓSTICOS

- K810 Colecistitis aguda
- K802 Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis

ÓRDENES

- Ecografía hepatobiliar. Justificación: Dolor en hipocondrio derecho con Murphy positivo.
- Hemograma, bilirrubinas, transaminasas. Justificación: Evaluar respuesta inflamatoria y descartar colestasis.
- Colecistectomía laparoscópica. Justificación: Colecistitis aguda litiásica confirmada por ecografía.

RESULTADOS

- Ecografía hepatobiliar: vesícula distendida, pared de 6 mm, cálculo de 18 mm en el cuello. Interpretación: Confirma colecistitis aguda litiásica.
- Hemograma: leucocitos 14.800. Interpretación: Respuesta inflamatoria.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El paciente o su representante recibe información sobre el procedimiento Colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general, sus riesgos y alternativas, y firma el consentimiento, que se anexa a la historia.

PLAN DE MANEJO

- Nada vía oral.
- Lactato de Ringer 1.000 mL intravenoso cada 8 horas.

- Ampicilina sulbactam 3 g intravenoso cada 6 horas.
- Colecistectomía laparoscópica.

EVOLUCIÓN

19-03-2026 14:44 · Día 2: Colecistectomía laparoscópica sin complicaciones, sangrado de 30 mL. Tolera vía oral líquida.

20-03-2026 10:08 · Día 3: Dolor controlado, deambula, heridas limpias.

EPICRISIS

21-03-2026 · Día 3: Egreso. Diagnóstico de egreso: colecistitis aguda litiásica, posoperatorio de colecistectomía laparoscópica. Plan: acetaminofén 1 g cada 8 horas por 5 días, curación de heridas, control en 8 días con patología.

PROFESIONAL

Atendido por: Yuli Amparo Pineda Pastrana. Firma: _____

Fecha de la anotación: 18-03-2026